PATOLOGÍA DE HIATO ESOFÁGICO Y ESFINTER ESOFÁGICO INFERIOR

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Iria Álvarez Torres, Mª Elba Palomares Ramos, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La funduplicatura es la técnica de elección para muchas de las patologías que afectan al esfínter esofágico inferior o al hiato esofágico.

La cirugía consiste en cerrar los pilares diafragmáticos y plicar el fundus gástrico para aumentar el grosor del esófago distal, dificultando la migración al tórax, y para aumentar la presión a nivel de la unión gastroesofágica, mejorando el cuadro de reflujo. La misma técnica se utiliza en los casos de achalasia por hiperpresión del EEI tras realizar la miotomía. En el caso de la hernia paraesofágica, con defectos generalmente mayores, puede ser necesaria una malla para reparar el defecto.

La funduplicatura puede ser de 360° alrededor del esófago (Nissen), solo de 180°-270° en su cara posterior (Toupet), o 90° anterior (Dor).



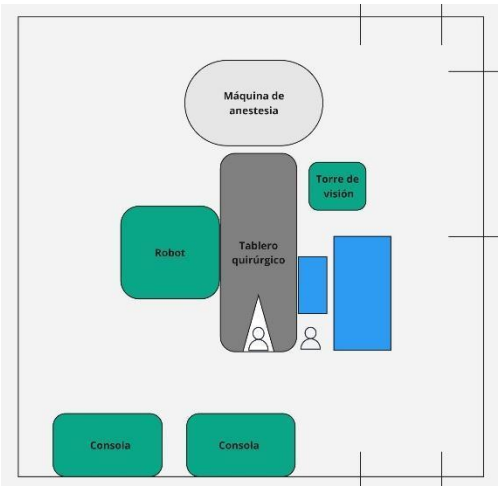
POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

- Decúbito supino.
- Brazos alineados con el cuerpo.
- Perneras bajas. Importante reforzar con foam la parte superior de ambas rodillas para tener una protección extra en caso de que los brazos del robot hagan contacto. Si el paciente es obeso y la sujeción de las perneras queda justa, se reforzará con venda crepé.

- Almohada de silicona para la cabeza.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

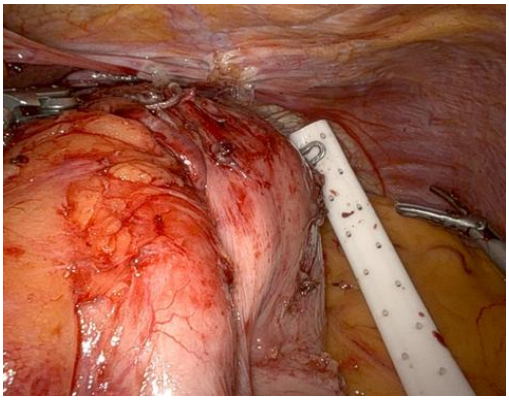
- Anatomía: abdominal superior
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Tip-Up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Endoscopio 30°
  - Brazo 4: Harmonic / Tijeras
- Tablero quirúrgico:
  - Anti-trendelemburg 12°
  - Piernas con ligera elevación

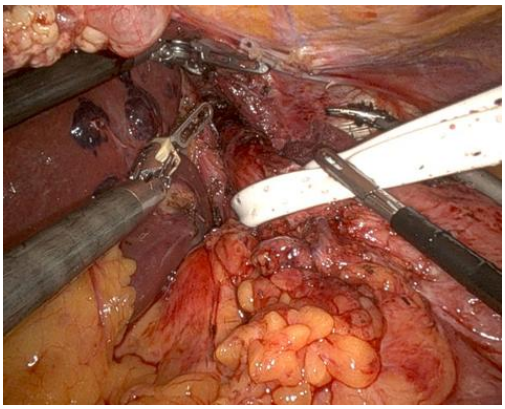




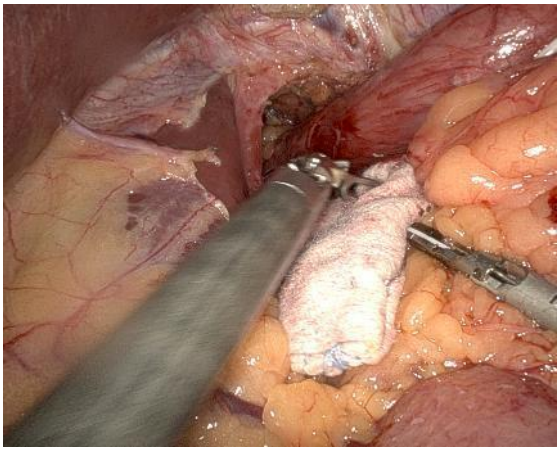
TÉCNICA QUIRÚRGICA

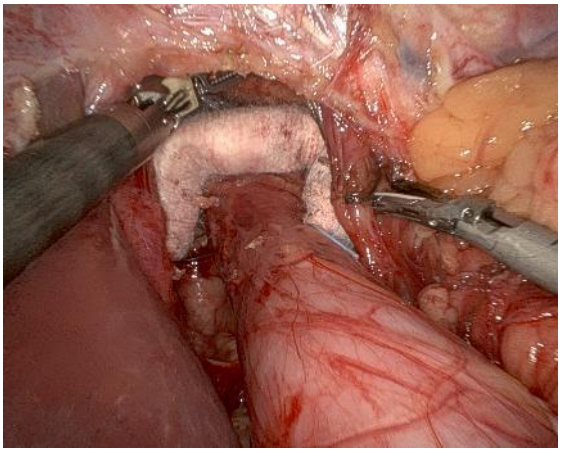
- Preparación de campo y colocación de trócares.
- Se libera el fundus gástrico mediante la sección de los vasos gástricos cortos.
- Colocación de accesorio para traccionar del estómago, puede ser una cinta de silicona tipo Jackson Pratt de 7Ch, y facilitar la disección del esófago hasta llegar a los pilares diafragmáticos.



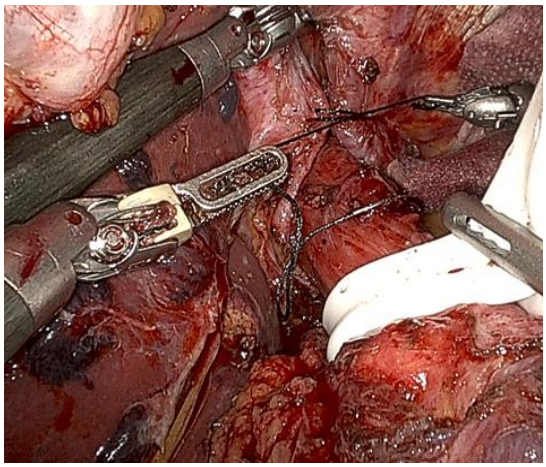


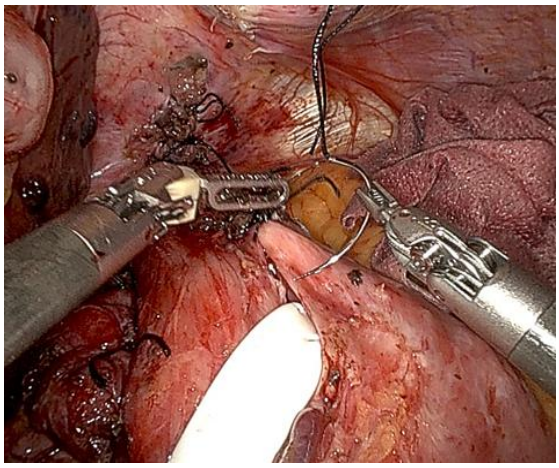
- Colocación de una sonda orogástrica de calibración 38 Fr para medir y comprobar la permeabilidad del esófago hasta el estómago. Liberación de adherencias si las hubiera y exposición del campo para plicatura y cierre de pilares si es necesario.





- Se envuelve el esófago, en diferentes grados según la técnica que se emplee, con el fundus gástrico para formar una valva.
- Recolocación de la sonda calibración para asegurar un diámetro óptimo durante el cierre de pilares.
- Se cierran los pilares por la parte superior e inferior del esófago con sedas calibre 0, cortadas a unos 18 cm.





- Se sutura la funduplicatura con seda 0 cortados a 15 cm.
- En el caso de que el paciente tenga una manometría muy precaria no se plica completo el fundus, sino que se fija a los laterales del esófago. Si se cerrara completamente el estómago sobre el esófago, el bolo alimenticio no podría vencer la presión y existiría el riesgo de quedarse con disfagia.
- Si se trata de una recidiva herniaria, se deshace la funduplicatura y se rehace.
- Si la disección ha sido muy laboriosa, en casos de cirugía de recidiva herniaria, se suele hacer test de estanqueidad, llenado la cavidad con suero e insuflando aire por una jeringa de 50cc.
- Colocación de drenaje, revisión de hemostasia y cierre de heridas.

NOTAS

Uso del bisturí armónico en el robot Da Vinci – En el caso de utilizar energía ultrasónica, para que esta pueda ser activada desde la consola del cirujano, se debe de unir la consola al robot, conectándole el cable gris del carro de visión a la toma del pedal de la consola.

BIBLIOGRAFÍA

1. Soliman BG, Nguyen DT, Chan EY, Chihara RK, Meisenbach LM, Graviss EA, et al. Robot-assisted hiatal hernia repair demonstrates favorable short-term outcomes compared to laparoscopic hiatal hernia repair. Surg Endosc. 2020;34(6):2495- 502.